

약제 급여 평가 위원회 평가 결과

Folate로서 4ml/병, 14ml/병
(Sodium Folate 100mg, 350mg)
(보리나2.5%주사, 명지약품)

☐ 제형, 성분·함량 :

- 1병(바이알) 중 Folate 100mg, 350mg

☐ 효능 효과 :

- 엽산대사길항제의 독성 경감
- 진행성대장암에서의 5-Fluorouracil(5-FU)과의 병용투여

☐ 약제 급여 평가 위원회 심의

2008년 제2차 약제급여평가위원회: 2008년 1월 25일

2008년 제12차 약제급여평가위원회 : 2008년 9월 26일[재평가]

- 암질환심의위원회 심의일: 2007년 11월 9일, 2008년 5월 14일, 2008년 9월 10일
- 중앙심사평가조정위원회 심의일 : 2007년 11월 12일

※ 약제급여평가위원회 평가결과중 해당 제약사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

○ 기심의결과 유지(비급여)

- 신청품은 “엽산대사길항제의 독성 경감, 진행성대장암에서의 5-FU과의 병용 투여”에 허가받은 약제로 5-FU와의 동시 투여가 가능하므로 편의성이 인정되나 그에 따른 비용효과성이 소명되지 아니하였고, 엽산대사길항제 독성경감 및 사용 비중을 고려한 진행성 대장암에서 Calcium folinate에 비하여 고가에 해당하므로 비급여함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “엽산대사길항제의 독성 경감, 진행성대장암에서의 5-FU과의 병용 투여”에 허가받은 약제로, “회귀질환”에 해당하지 않으며, 현재 동 적응증에 허가받은 “*Calcium folinate*” 주사제(3mg, 15mg, 30mg, 50mg, 100mg)가 급여 목록에 등재되어 있으므로, 대체가능성을 고려시 진료상 반드시 필요한 약제에 해당되지는 않음.

○ 임상적 유용성

- 교과서 및 가이드라인에는 신청품인 Sodium folinate의 염기 차이에 관한 내용은 특별히 언급되어 있지 않음.
- 신청품과 Calcium folinate 제제와의 비교임상시험 문헌은 검색되지 않았으며, 임상연구는 대부분 Calcium folinate를 사용한 것임.
 - 동 약제에 대한 의학적 타당성을 입증할만한 자료는 충분치 않으나, 동 약제가 기존의 “Calcium folinate”와 염기만 바뀐 점을 고려하여 비용 효과성에 대한 검토가 우선되어야 할 것으로 판단됨¹⁾.
 - 전이성 대장암 환자에서 신청품과 5-FU의 동시 투여에 관한 단독임상시험 결과, 5-Fu와 Sodium folinate의 동시 투여가 가능하며²⁾ 106번의 투여주기 동안 카테터 막힘 현상을 보이지 않았음.³⁾

○ 비용 효과성

- 신청품의 대체약제 및 비교약제는 Calcium folinate 제제임.
- 신청품은 “Calcium folinate” 주사제의 ‘Calcium염’을 ‘Sodium염’으로 변경시킨 염변경 약제로 자료제출 의약품에 해당하여 100mg 제품의 경우 개량신약 경제성 평가 세부기준(보험약제팀-1927 2007.7.27)에 따라 검토시 비용효과적이지 않음.
 - 5-FU infusion 시간을 고려할 때 Ca-FA 전처치 2시간 투약시간 단축이 갖는 의미가 크지 않을 것으로 보이며 이로 인한 비용 감소에 대한 부분은 제약사가 소

명하지 못하였음.

- 투약비용 비교시 진행성 대장암의 고용량 용법(용법1)²⁾에서는 저가에 해당하나, 진행성 대장암의 저용량 요법(용법2)³⁾ 및 엽산 대사길항제 독성 경감에서 모두 고가에 해당함.
 - 전문가 의견⁴⁾ 및 06년 청구량으로 용법 1)2)의 사용비율 추정시⁵⁾ 용법1)이 약 60%, 용법2)가 약 40% 비율로 사용되는 것으로 추정됨.
 - 제약사에서는 50mg 제제를 제조사의 미생산을 이유로 허가취하 하여 저함량 필요요법에서 고함량 제제로 대체될 경우 비용이 증가할 수 있음.

○ 재정 영향

- 제약사 제시 예상 사용량을 기준으로 신청품 등재후 절대 재정소요금액은, 등재 후 1차년도에 ■■■■, 3차년도에 약 ■■■■이 되고, 결정신청된 100mg은 기존의 100mg 제제를, 350mg 함량제제는 100mg와 50mg를 대체할 것으로 가정시, 재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■■, 3차년도에 약 ■■■■ 가량 증가될 것으로 예상됨.

○ 제 외국 등재 현황⁶⁾

- A7 국가중 독일에 100mg, 350mg, 500mg, 1000mg 함량이 등재(4ml, 14ml, 20ml, 40ml)되어 있음.

Reference

- 1) 2008년 7차(제34차) 암질환심의위원회(2008.9.10)
- 2) 1일 폴리네이트로서 200mg/m²을 최소 3분 이상 천천히 정맥주사하고 계속해서 5-FU 370mg/m²을 정맥주사함.
- 3) 1일 폴리네이트로서 20mg/m²를 정맥주사하고 계속해서 5-FU 425mg/m²를 정맥 주사한다. 위의 치료를 5일 동안 계속하고, 이를 4주 간격으로 반복함.
- 4) 암질환심의위원회 전문위원 ■■■■에게 용법1)2)의 사용비율 질의 결과, Folfox 용법에 서도 Leucovorin 고용량 혹은 저함량 제품 모두 사용하는 regimen이 있으며, 병원이나 임상 의에 따라 사용이 달라 용법 1)이 절대적으로 많이 사용되지는 않을 것으로 보임.
- 5) 06년 총청구량을 총투여일수로 나누어 일일투약량을 추정하고, 총청구량을 일일투약량으로 나누어 함량별 사용 빈도를 추정함. 이때 일일 200mg 이상(고함량)과 200mg미만(저함량)으로 분석결과 고용량:저함량의 사용비율은 약 1.5:1(60%:40%)로 추정됨.
- 6) 2007 Rote List에는 100mg, 350mg 함량만이 수록되어 있었으나, 2008년 책자에는 100mg(4ml), 350mg(14ml), 500mg(20ml), 1000mg(40ml) 제제가 모두 수록되어 있음.